

10 その他の生検法 other biopsies

A 前斜角筋リンパ節生検 scalene (lymph) node biopsy (Daniels' biopsy)

到達目標

- 前斜角筋リンパ節生検の目的、適応が理解できる
- 前斜角筋リンパ節生検の手技について説明できる
- 前斜角筋リンパ節生検の合併症が理解できる

1 目的

前斜角筋リンパ節などのリンパ節生検は、癌のリンパ節転移、結核性リンパ節炎、悪性リンパ腫、サルコイドーシスなどの原疾患の診断とともに、悪性疾患においては病期診断のために行われる。前斜角筋リンパ節生検は Daniels' biopsy として知られている。

2 適応と禁忌

前述の疾患などの確定診断が必要で、原則として、①診察にてリンパ節が触知できる症例、②リンパ節が触知できなくとも CT, PET, 頸部エコーなどの画像検査にてリンパ節腫大が確認される症例が対象となる。サルコイドーシスなどの一部の症例においては診察、画像などにてリンパ節腫大が確認できない場合でも、鎖骨上窩の脂肪組織を一塊として摘出する fat pad biopsy が行われることもある。出血傾向などがある症例においては注意が必要であるが、絶対的禁忌はない。

3 検査手技

前斜角筋リンパ節生検について解説する（図 1）。

麻酔は局所麻酔で行う。

a 検査の手順

- ①仰臥位で顔を生検側と逆側に横向きとする。
- ②鎖骨上窩で、胸鎖乳突筋外縁から鎖骨に平行に 3～4 cm の皮膚切開を行う（図 1a）。
- ③直下の広頸筋を横切り筋膜を開くと、前斜角筋脂肪組織が露出する（図 1b）。この部位は scalene triangle と呼ばれ、内側を内頸静脈、外側を肩甲舌骨筋、下縁を鎖骨下静脈にて境される。この脂肪組織内のリンパ節の位置を触診にて再確認する。
- ④触知したリンパ節の直上で脂肪繊皮膜を開き、リンパ節周囲の結合織を剥離し、リンパ節を摘出する。

b 手技のポイント

皮膚切開は美容上の問題から 2～2.5 cm 程度にする場合もあるが、切開が小さすぎるとリンパ節の摘出が難しい。検体の処理は疑われる疾患によって異なるが、ホルマリン固定用の標本以外に、培養用や、遺伝子や染色体検査、フローサイトメトリーによる表面抗原の検索のために生組織あるいは凍結組織などが必要となることもある。

4 合併症

重大な合併症はほとんどない。内頸静脈を損傷した場合は視野も保たれており対応しやすいが、鎖骨下静脈損傷については鎖骨切除が必要となることもある。まれに横隔神経損傷、乳び漏、気胸などがみられる。

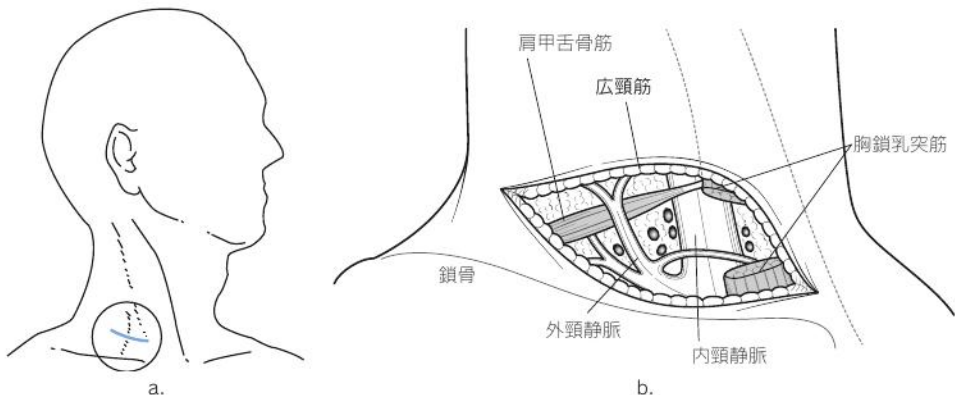


図 1 前斜角筋リンパ節生検
a: 皮膚切開の部位, b: 前斜角筋付近の解剖